

A Subjectivity Study on the Speech Language Therapy of Children with ASD of Speech Language Pathologist

Miseung Song, Soyoung Choi, & Soop Choi

Abstract: This study was conducted to explore the strategy method for improvement about professional competence of speech language pathologist by identifying the perception types and characteristics of speech language pathologist who works in children with ASD. The research method was applied with Q-methodology, and 30 speech language pathologist with experience of speech language therapy for children with ASD were to be forced to distribute 40 Q-samples. The collected data was treated with principle component factor analysis by the PC QUANL program. The types of speech language pathologist are classified in three types. Type 1 was identified as an 'academic knowledge-based expert pursuit type' that aims to continuously develop expertise based on an academic knowledge base with a sense of mission to speech language therapy. Type 2 was identified as a 'professional job performance complacency type' that did not study the latest literature or introduce new treatment methods, and did not feel the need for introducing new policies. Finally, the type 3 was identified as a 'guardian of an expert system based on communication type' who recognizes the importance of collaboration with other disciplines and communication with parents. An exploratory study is needed to find a systematic device for cultivating the professional competence of speech language pathologists who treat ASD children and a way to establish an expert system for each speech and language disorder.

Key Words: Children with ASD, Speech Language Pathologist, Speech Language Therapy, Subjectivity Study, Perception Type

언어재활사의 ASD 아동 언어치료에 대한 주관성 연구*

송 미 승** · 최 소 영*** · 최 숲****

연구 목적: 본 연구는 ASD 아동을 치료한 언어재활사의 인식유형과 그 특성을 살펴봄으로써 언어재활사의 전문적인 역량을 향상시키기 위한 전략 방안을 탐색하고자 수행되었다.

연구 방법: Q 방법론을 적용하여 ASD 아동 치료경험이 있는 언어재활사 P표본 30명을 대상으로 하였으며, 이들이 40개의 Q표본을 Q-표본 분포도 상에 분류하게 하였다. 수집된 자료는 PC-QUANL program에 의한 주요인분석법으로 처리하였다.

연구 내용: ASD 아동을 치료한 언어재활사 유형은 3가지 유형으로 나타났다. 1유형은 언어치료에 대한 사명감을 가지고 학문적 지식 기반을 토대로 지속적으로 전문성을 발전시켜 나가고자 하는 '학문적 지식 기반의 전문가 추구형'으로 확인되었다. 2유형은 최신문헌을 연구하거나 새로운 치료방법을 도입하지 않으며, 새로운 정책 도입에 대한 필요성도 느끼지 않는 '직업적 업무 수행 안주형'으로 확인되었다. 마지막으로 3유형은 타학문과의 협업이나 특히 부모와의 소통을 중요하게 인식하는 '소통기반의 전문가 체계 수호형'으로 나타났다.

결론 및 제언: ASD 아동을 치료하는 언어재활사들의 전문적인 역량을 함양하기 위한 제도적인 장치와 각 말·언어장애에 대한 전문가 체계 확립 방안 모색을 위한 탐색적 연구가 필요하다.

핵심어: ASD, 언어재활사, 언어치료, 주관성 연구, 인식유형

□ 접수일: 2022년 11월 7일, 수정일: 2022년 11월 24일, 게재확정일: 2022년 12월 20일

* 이 논문은 2022학년도 세한대학교 대학연구비의 지원을 받아 수행된 것임.

** 주저자, 세한대학교 간호학과 교수

(First Author, Professor, Sehan Univ., Email: sms595600@naver.com)

*** 공동저자, 목포언어청각센터장(Co-author, Researcher, Mokpo Speech Language Hearing Center, Email: sabjiwalla@hanmail.net)

**** 교신저자, 강남이화말언어연구소 연구원(Corresponding Author, Researcher, Ehwa Speech-Language Center, Email: soop75@naver.com)

www.kci.go.kr

I. 서론

자폐스펙트럼장애(ASD: autism spectrum disorder)는 인지, 언어, 운동 및 사회성 발달에 지체를 보이는 신경발달장애이다(APA, 2013). DSM-5(APA, 2013)에 따르면 ASD의 진단 근거는 첫째, 다양한 맥락에 따른 사회적 의사소통과 사회적 상호작용에 지속적인 결함이 있으며 둘째, 제한적이고 반복적인 행동, 흥미 혹은 활동을 보이고 셋째, 이러한 증상들이 초기 발달기에 나타나 이후에 사회, 직업 혹은 기타 중요한 기능에서 임상적으로 유의미한 손상을 일으키는 경우를 말한다. ASD가 발생하는 비율은 미국의 경우 2005년에는 1,000명 중 7명 비율에서 2014년에는 1,000명 중 15명의 비율로 증가하였다(Beverly & Mathews, 2021). 우리나라 역시 ASD로 등록된 장애인 수가 2008년 12,954명에서 2018년 26,703명으로 꾸준히 증가하고 있는 추세이다(장애통계연보, 2019). 이러한 유의미한 증가는 평가, 조기 중재, 취학 전 프로그램 그리고 특수교육이 필요한 ASD 아동이 점점 더 많아지고 있다는 것을 의미한다.

ASD가 보이는 여러 가지 특성 중 언어능력을 살펴보면 이들의 의사소통능력은 무발화수준에서 대화 상황에 적절하게 참여할 수 있는 수준까지 폭넓고 다양하며 그 내용면에서 일반 아동과는 다른 특이한 양상을 보이고 있다. 인지능력과 언어 능력간의 불일치를 보인다거나, 표현어휘에 비해 수용어휘발달이 지체된다는 점(Loucas et al., 2008), 생후 1년 즈음에 적어도 3개의 낱말을 사용하다가 어떠한 낱말도 사용하지 않는 기간을 보이는 아동들이 있다(Lord et al., 2004). 또한 ASD 아동 중에는 인지기능이 정상범주에 있으면서 조음능력, 언어의 구문론적·형태론적 발달은 대체로 정상적인 발달을 거치지만 특히 화용언어 능력에 결함을 보이는 아동들이 있다. 이들의 발화를 살펴보면 형식면에서 문법적으로 유창한 발화를 하더라도 그 내용면에서 이상한 구나 낱말을 선택하는 의미적 결함을 나타내며, 일상적인 의사소통에 심각한 문제를 보이지 않더라도 연령이 높아짐에 따라 사회적 상호작용을 저해할 수 있는 의사소통의 질적인 손상이 나타나게 된다(Church et al., 2000). 이와 같이 ASD 아동이 가지고 있는 언어특성이 무발화 수준에서 유창한 발화 수준까지 다양한 양상으로 나타나므로 자폐 증상의 정도를 스펙트럼이라는 용어를 사용하여 증상의 개인적인 편차에 대한 설명이 가능하게 되었다(이승희, 2014). 즉 동일하게 ASD 진단을 받았더라도 개인 각각의 능력과 특성이 서로 다르고 독특하기 때문에 각 개인에게 필요한 치료적 요구가 달라질 수 있다.

언어재활사가 ASD를 선별하고 진단하며, ASD 아동의 성장과정 및 전 발달과정상의 삶

의 질과 사회적 의사소통능력을 증진시키는데 매우 중요한 역할을 한다(ASHA, 2006). 따라서 초기에 언어재활사가 제공하는 치료는 ASD 아동의 언어와 사회적 의사소통 발달 및 예후에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 그러나 임상 현장에서 언어재활사가 대상자에게 필요한 치료 목표를 설정하고, 치료방법과 전략 및 치료 활동 계획을 세울 때 많은 어려움을 호소하는 장애 중 하나가 ASD로 언급되고 있다(김시영 외, 2020). ASD의 치료에 대한 언어재활사의 준비도와 전문성을 조사한 연구에서 참여자 중 69%의 언어재활사가 정규과정에서 ASD 임상실습 기회가 너무 적었다고 응답했다(Cascella & Colella, 2004). 또 다른 연구에서는 참여자 중 50%만이 ASD 진단 기준을 명확하게 알고 있었으며, 대부분의 언어재활사는 ASD 아동의 효율적·전문적 치료기법에 대한 자신감이 부족한 것으로 나타났다(Beverly & Mathews, 2021). ASD 언어치료는 ASD의 언어특성 뿐 아니라 의학적인 지식을 근거로 한 진단 기준, 다른 장애에서 관찰되지 않는 독특한 행동 특성, 근거에 기반한 다양한 치료기법 등 여러 가지 지식이 필요한 전문적인 영역이다.

ASD 및 ASD의 언어치료에 관한 연구가 다양하게 이루어지고 있으나, 주로 ASD 치료 방법 및 언어재활사의 ASD에 대한 인식 등에 관한 연구들로서, ASD를 치료하는 언어재활사들의 태도 및 인식유형에 대해 알아보는 것은 큰 의미가 있다고 생각된다. ASD에 대한 지식 습득의 어려움, 임상실습 경험 부족 등으로 다각적인 접근이 필요한 ASD 치료에 대해 언어재활사들이 상당한 부담감을 느끼고 있음을 선행연구를 통해 확인하였다. 이에 ASD 아동에게 적합한 언어치료를 제공하기 위해 언어재활사가 주관적으로 경험한 ASD에 대한 태도 및 인식유형을 파악해 볼 필요가 있다. ASD 아동의 언어치료에 대한 태도는 주관적이고 개별화된 경험으로 각 개인의 특성과 가치관 및 경험의 정도, 사회문화적 상황 등에 따라 매우 다양하므로, 개인의 내재된 관점에서 자신의 주관성을 표현하게 해야 한다. 이렇듯 언어재활사의 주관성을 표현하기에 적합한 Q 방법론을 적용하여 ASD 아동의 언어치료에 대한 태도의 본질을 파악할 필요가 있다.

이에 본 연구는 Q 방법론을 적용하여 ASD 아동 치료 경험이 있는 언어재활사의 주관적 구조 파악 및 인식유형과 그 특성을 탐색하여 ASD 아동을 치료하는 언어재활사의 전문성 강화 등의 능력을 향상시키기 위한 전략 방안 마련의 기초자료를 제공하고자 한다.

II. 연구방법 및 내용

본 연구는 언어치료임상현장에서 ASD 아동 치료경험이 있는 언어재활사들을 대상으로 ASD 아동 치료에 대한 언어재활사들의 주관성 및 인식구조와 유형별 특성을 확인하기 위해 Q 방법론을 적용하였다.

1. 연구절차

1) Q모집단 및 Q표본 선정

본 연구에서는 ASD 아동에 대한 선행문헌을 확인하고, 현재 임상현장에서 일하고 있는 언어재활사를 대상으로 2020년 10월 31일부터 2021년 6월 30일까지 심층면담을 실시하였다. 한 명의 대상자에게 실시한 면담시간은 1시간 30분에서 2시간 30분 정도였다. 선행연구 및 문헌 고찰을 통해 추출한 문장을 포함하여 총 66개의 문항으로 Q모집단을 완성하였다. 마지막으로 추출된 진술문에 대한 수정과정을 통해 최종 40문항의 Q표본을 선정하였다. 도출된 문항들의 신뢰도 검증을 위해 언어재활사 2인에게 미리 사전검사를 실시하였으며, 각 사람마다 시간 차를 두고 Q sort를 다시 실시하여 확인하는 방법으로 신뢰도를 높였다(김흥규, 2008). 이후 모호한 표현 및 Q sort에서 차이가 나는 Q표본 등을 수정하였으며, 내용타당도 검증은 Q 방법론에 대한 연구 경험이 풍부한 교수 1인에 의해 수행되었다.

2) P표본 선정

본 연구는 ASD 아동 치료 경험이 있는 언어재활사 30명을 대상으로 P표본을 선정하였다. 본 조사는 연구의 목적과 과정에 대해 연구자로부터 설명을 듣고 동의한 연구참여자에게 2021년 11월 5일부터 2021년 11월 24일까지 실시하였다. P표본 특성은 <표 1>에 제시하였다.

3) Q표본 분류

최종 선정된 40개의 Q 표본이 인쇄된 카드를 P표본인 연구대상자에게 제시하고, 진술문을 읽고 이해하게 한 후, 자신의 의견에 따라 분류하도록 하였다. 진술문을 읽고 가장 긍정 하는 진술문(+4)에서부터 차례대로 선택하여 중립적인 진술문(0)를 마치도록 하였으며 동

일하게 가장 부정하는 진술문(-4)에서 중립적인 진술문(0)으로 분류하도록 하였다(그림 1). 이때 Q 요인의 의미를 해석하기 위해 양쪽 끝에 놓인 가장 긍정하는 진술문 3개, 가장 부정하는 진술문 3개에 대한 선정 이유를 면담하고 정리하였다.

3	4	6	7	9	7	6	4	3
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
←적극 부정			중립			적극 긍정→		

〈그림 1〉 Q표본 분포도

4) 자료 분석

수집한 자료를 9점 척도상에 가장 부정하는 문항을 1점으로, 가장 긍정하는 문항을 9점으로 점수화하여 코딩하였다. 자료 분석은 PC-QUANL program을 통한 주요인 분석법을 적용하였다. 전체 변량에 대한 설명력을 높이기 위해 아이겐 값(eigenvalue) 1.0 이상을 기준으로 요인수를 산출하였으며, 적합한 문장을 선정하기 위해 표준점수(Z-score)를 사용하였다. 이렇게 산출한 결과와 설명변량을 고려하여 최적의 유형을 선택하였다.

III. 연구결과

1. Q 유형의 형성

ASD 아동의 언어치료에 대한 주관성을 Q 요인 분석한 결과 3개의 유형으로 확인되었다(표 1). 이들 3개 유형은 1유형 40.91%, 2유형 7.68%, 3유형 5.71%를 설명하여 3개 유형이 전체 변량의 54.3%를 설명하는 것으로 나타났다. Q 요인별 가중치가 높은 사람은 자신이 속한 Q 요인을 대표하는 특성을 나타내므로 각 유형 별 Q 분류에 기여도가 높은 대상자임을 의미한다. 인자가중치가 높은 사람일수록 그가 속한 유형에 있어서 그 유형을 대표할 수 있는 전형적 혹은 이상적인 사람이다.

상관관계는 각 유형 간의 유사성의 정도를 보여주는 것으로, 제시된 3개 유형 간의 상관관계는 낮게 나타남으로써 각 유형 간의 독립성이 입증되고 있다(표 3).

〈표 1〉 P표본의 특성과 인자가중치

유형	대상자번호	인자가중치	연령	근무지	학력	경력	거주지
제 1유형 (N=13)	26	2.5906	36	사설치료	석사	13	충남
	27	1.6161	47	사설치료	박사	20	경기
	29	1.4953	28	사설치료	석사	5	경기
	22	1.3813	28	사설치료	석사	3	경기
	3	1.3084	49	사설치료	석사	14	전남
	28	1.2839	48	사설치료	석사	6	경기
	30	.9525	46	사설치료	석사	8	서울
	16	.9028	43	병원	석사	15	서울
	25	.8651	32	사설치료	석사	9	충남
	14	.8403	32	사설치료	석사	9	광주
	10	.7543	30	복지관	학사	6	전남
	9	.6416	33	복지관	학사	10	전남
	18	.5451	44	사설치료	석사	15	서울
제 2유형 (N=5)	6	2.7589	26	복지관	학사	3	전남
	4	1.3596	30	사설치료	학사	7	전남
	7	1.0350	35	복지관	학사	11	전남
	11	.9197	37	어린이집	학사	8	전남
	24	.4253	30	사설치료	석사	6	서울
제 3유형 (N=12)	5	2.1833	43	복지관	학사	15	전남
	13	1.4332	30	사설치료	박사	6	광주
	17	1.3093	34	병원	석사	11	서울
	15	1.2602	48	사설치료	박사	17	전남
	19	1.1747	48	사설치료	석사	16	서울
	21	1.0702	44	사설치료	박사	15	경기
	2	.9061	26	사설치료	학사	3	전남
	20	.8736	46	병원	석사	20	서울
	8	.6076	40	복지관	학사	11	전남
	12	.6069	31	사설치료	박사	8	광주
	1	.5854	28	사설치료	학사	5	전남
	23	.5191	48	사설치료	석사	1년	경기

〈표 2〉 유형별 아이겐값과 변량

Variable	Type 1	Type 2	Type 3
Eigenvalues	12.2743	2.3036	1.7119
Variance	0.4091	0.0768	0.0571
Total Variance	0.4091	0.4859	0.5430

〈표 3〉 상관계수

	Type 1	Type 2	Type 3
Type 1	1		
Type 2	.32	1	
Type 3	.68	.39	1

2. 유형 분석

1) 제 1유형: 학문적 지식 기반의 전문가 추구형

1유형으로 분류된 대상자는 전체 30명 중 13명이었다. 1유형은 ‘아동이 진전을 보일 때 뿌듯하게 느끼며 보람이 있다’, ‘언어치료 진전이 없을 때는 논문을 보는 등 공부를 하거나 동료치료사와 케이스 스터디, 토론 등 함께 협업한다’, ‘의학적인 지식 등 다른 학문들과 협업을 통해 상호 협력하는 치료가 필요하다’ 등의 항목에서 강한 동의를 보였다. 반면 ‘ASD 아동은 치료하면서도 호전될 것이라는 기대가 낮다’, ‘아동의 공격적인 문제행동(꼬집고, 때리고 등) 및 연령에 맞게 놀아주는 일이 육체적으로 힘들다’ 등의 순으로 강한 비동의를 보였다(부록 1). 1유형에서 가장 높은 인자가중치를 보인 대상자가 가장 긍정적인 진술문을 선택한 이유를 살펴보면, “치료는 진전을 보여주어야 하는 업무이기에 꾸준히 치료에 대한 점검이 필요하다고 생각한다. 진전이 없을 때 자가 점검 후 논문을 통해 근거중심 증재방향에 대해서 다시 모색하는 등을 우선순위로 한다.”, “대상자를 더욱 정확하게 파악하고 진전을 확인하려면 의학적 지식 등 다른 학문의 전문가들과의 상호 협업이 필요하다.”라고 하였다. 이러한 면담내용을 토대로 볼 때, 1유형은 언어치료에 대한 사명감을 가지고 철저한 치료준비를 통하여 치료의 효율성을 높이하고자 노력하며 학문적 지식 기반을 토대로 하여 지속적으로 전문성을 발전시켜 나가하고자 하였다. 따라서 이러한 주관성을 가진 1유형을 ‘학문적 지식 기반의 전문가 추구형’으로 명명하였다.

2) 제 2유형: 직업적 업무수행 안주형

2유형으로 분류된 대상자는 전체 30명 중 5명이었다. 2유형은 ‘우리나라는 언어치료를 모르는 사람이 아직도 많으며, 자폐에 대한 이해도가 낮다’, ‘발화산출을 위해 눈, 손 협응 내지 인지활동 등을 같이 진행한다’, ‘아동의 공격적인 문제행동(꼬집고, 때리고 등) 및 연령에 맞게 놀아주는 일이 육체적으로 힘들다’ 등의 항목에서 강한 동의를 보였다. 반면 ‘치

료 도구는 인터넷, 최신 저널을 검색하는 등 스스로 공부해서 직접 만들어 사용한다', '언어재활사도 각 영역(ASD, 말더듬 등)의 분야별 전문가 체계를 도입하여 제도화해야 한다.' 등의 항목에 강한 비동의를 보였다(부록 1). 이 유형에서 대표성을 띠는 대상자를 중심으로 가장 긍정적인 진술문을 선택한 이유를 보면, "지금의 실습시간, 커리큘럼, 교과목 등 알맞게 이루어져 있어 개편이 필요하지 않는 것 같다.", "치료가 많은 날 연령이 낮은 아동 치료가 연달아 있으면 체력적으로 굉장히 고되고 나이 들어서도 할 수 있을지 고민이 된다.", "새로운 도구에 대한 검색은 해보지만 직접 만들지는 않는다."라고 진술하였다. 이상의 결과를 토대로 볼 때, 2유형은 ASD 아동의 언어치료 과정을 힘겨워 하면서도 치료의 질을 높이기 위하여 최신 문헌 연구를 하거나 새로운 치료 방법을 직접 도입하지는 않는다. 또한 현재의 언어재활 체계나 교육과정에 대하여 대체로 만족하며 분야별 전문가 체계나 언어재활사로서 전문성을 인정받기 위한 새로운 정책 도입에 대한 필요성도 느끼지 않았다. 이에 '직업적 업무수행 안주형'으로 명명하였다.

3) 제 3유형: 소통기반의 전문가 체계 수호형

3유형으로 분류된 대상자는 전체 30명 중 12명이었다. 3유형은 '언어재활사도 각 영역(ASD, 말더듬 등)의 분야별 전문가 체계를 도입하여 제도화해야 한다', '언어재활사에 대한 부모의 믿음이 치료 결과에 좋은 영향으로 작용한다', '의학적인 지식 등 다른 학문들과 협업을 통해 상호 협력하는 치료가 필요하다' 등의 항목에서 강한 동의를 보였다. 반면 '상황이 달라지면 적용을 못하므로 거의 모든 상황을 새로 가르쳐야 해서 힘들다', 'ASD 아동은 치료하면서도 호전될 것이라는 기대가 낮다' 등의 항목에 강한 비동의를 보였다(부록 1). 이 유형에서 대표성을 띤 대상자의 진술을 보면, "말더듬, 신경언어, ASD 등 각 분야별 전문가 체계를 도입하는 것이 치료사와 내담자 모두에게 효과적이라고 생각한다.", "각각의 장애군에 대한 강점과 약점을 상호보완하기 위해서는 다양한 학문과 협력한다면 시너지 효과를 기대할 수 있다.", "부모의 믿음과 라포가 치료 결과에 도움이 된다."라고 진술하였다. 이상의 결과를 토대로 볼 때, 이 유형은 영역별 전문가 체계의 제도적 장치 도입을 가장 절실하게 바라고 있다. 또한 ASD 아동의 언어치료에 있어서 치료사의 역량도 중요하지만 타학문과의 협업이나 특히 부모와의 소통을 매우 중요하게 인식하였다. 따라서 이러한 주관성을 가진 3유형을 '소통기반의 전문가 체계 수호형'으로 명명하였다.

4) 공통적 견해

본 연구에서 분류된 유형과 관계없이 언어재활사의 ASD 아동의 언어치료에 대해 공통적으로 일치된 견해를 보인 진술문이 있었다. 표준점수 1.00 이상의 동의를 보인 진술문은 ‘아동과 부모와의 질적인 상호작용이 결여되면 치료의 한계가 있다’이었으며, 낮은 동의를 보인 진술문은 ‘아동의 컨디션을 고려하지 않고 나의 치료계획대로 언어적인 자극을 준다’, ‘부모 상담 시 아동이 잘 못하는 부분을 주로 강조하여 설명한다’였다. 각 유형에서 공통된 동의 항목을 보면, 언어치료 시 아동과 부모와의 효과적인 소통을 중요시 하는 것으로 보인다. 공통적으로 부정한 항목은 세 유형 모두 강하게 부정하여, 언어재활사로서 가장 기본적인 윤리적인 소양이 갖추어져 있음을 나타낸 것으로 보인다.

IV. 논의 및 결론

본 연구에서 나타난 언어재활사의 ASD 아동 언어치료에 대한 주관성은 학문적 지식 기반의 전문가 추구형, 직업적 업무수행 안주형, 소통기반의 전문가 체계 수호형의 3가지 유형으로 나타났다. 제 1유형은 ‘학문적 지식 기반의 전문가 추구형’으로 ASD 아동에게 언어치료 제공 후 아동의 발전적인 상태 호전 및 진전이 있어야 하므로, 치료에 대한 성과관리의 필요성 및 논문 검색, 타 학문의 전문가들과의 협업을 통하는 등의 꾸준한 학문적 지식활동을 토대로 한 진정한 전문가를 추구하는 것으로 나타났다. 언어재활사가 적절한 시기에 정확한 지도 목표에 의한 언어재활 프로그램을 제공하는 경우 ASD 아동의 언어 발달 촉진에 도움을 주기 때문에(신문자, 2002), 언어재활사의 역할이 매우 중요하다고 할 수 있다. 언어재활사들이 가장 이루고 싶은 목표로서 전문성을 갖춘 유능한 치료사를 꼽았으며, 이를 위해 치료능력 향상, 전문지식 공부 등의 전문성 강화가 필요하다는 전선영(2017)의 연구가 본 연구를 지지한다. 따라서 성공적인 언어치료를 위해서는 언어재활사들의 전문성이 요구되어, 지식, 기술 등의 필수적 역량이 필요하다(심재찬, 2016).

1유형은 실제 현장 치료 시 치료의 진전을 위해서 논문 검색 등의 공부 및 치료 점검 등의 꾸준한 관리가 언어재활사에게 꼭 필요한 주요 업무로 꼽았다. 이는 아동의 증상에 따라 구체적이고 면밀한 치료계획을 세워 언어재활사로서의 업무를 충실히 수행해야 한다는 Richard(2011)의 연구와 일맥상통하는 부분이다. 따라서 ASD 아동을 치료하는 언어재활사들의 전문성 향상을 위한 교육 및 연구 등의 개발 시 최대한 어렵지 않게 ASD 아동 치료

에 접근할 수 있도록 학사과정에서부터 교과과정의 세밀한 접근이 필요해 보이며, 이와 연계된 전략적 방안 모색이 필요할 것으로 사료된다.

‘직업적 업무수행 안주형’으로 명명한 제 2유형은 전체 대상자 중 5명으로 가장 적은 분포를 보였다. 2유형이 1유형과 가장 큰 차이를 보인 진술문은 아동의 공격적인 문제행동 및 연령에 맞게 놀아주기, 치료의 진전이 없거나 아동에게 다른 상황이 발생할 때마다 새로 가르치는 일 등을 매우 힘겨워하는 것으로 나타났다. 언어재활사가 현장에서 겪는 어려움 중 치료 영역에서는 중증 장애, 뇌병변장애 등과 함께 ASD가 언급되었으며, 치료 수행 시의 어려움으로 대상자의 문제행동 및 우발적 상황 발생 시의 대처가 어렵다(김시영 외, 2020)는 선행연구가 본 연구를 뒷받침한다. ASD 아동의 언어치료는 언어 문제와 함께 문제행동에 대한 대처능력이 치료의 중요한 핵심적인 요인으로 작용하나, 실제 임상현장에서는 문제행동 및 돌발적 상황에 대한 대처가 어려워 치료 수행의 범위가 제한되기도 한다. 한유진·이선아(2015)의 연구에서 ASD 아동의 문제행동을 위한 중점적 교육에 대한 요구도가 높게 나타남에 따라 2유형 대상자들이 호소하는 어려움에 대해 어느 정도 공감대가 형성되어 있다고 여겨진다. 한편 2유형은 언어치료 시 선호하는 장애유형이 있으며, 치료에 대한 공부 및 최신 저널 검색 등 치료 도구를 만들어 적용하기, 언어치료학문의 분야별 전문가 체계 도입의 필요성, 전문성 인정 및 처우개선을 위한 정책 변경 등에 부정적인 의사표시를 함으로써 1유형과는 정반대의 의견을 표명하였다. 이는 언어재활사로서의 유능함은 치료능력에 대한 인정으로 이어지며, 이러한 유능함을 증진하기 위한 일환으로 전문성 신장 및 강화에 주력한다는 김태우(2016)의 연구결과와는 상반된 결과이다. 또한 언어재활사들의 불합리한 처우 및 치료의 질 향상을 위해 체제 개선 및 정책 변화가 필요하다는 전선영(2017)의 연구와도 상반된 견해를 보였다. 2유형은 문제행동을 보이는 아동 치료 시 육체적으로 힘들며, 스스로 공부하는 모습은 보이지 않는 등 대체로 현재의 치료환경에 대해 안주하는 편으로, 전문가 체계 도입 및 처우개선을 위한 정책 변경 등에 부정적인 의사표시를 함으로써 김태우(2016), 전선영(2017)의 선행연구와 차이를 보였다. 언어재활사의 질 높은 언어치료 제공 및 전문성 증진을 위해 직무 등의 교육과정 개발이 필요할 것(김유경·장현진, 2019)으로 사료되므로, 2유형이 언어재활사로서의 자부심을 갖고 전문성 증진을 위한 학문적·실제적인 노력을 할 수 있도록 다양한 형태의 콘텐츠 및 참여 유도 방법 등의 개발을 제안한다.

제 3유형의 대상자들은 ‘소통기반의 전문가 체계 수호형’으로서 언어치료학의 전문성 신장 및 학문적 지식 욕구보다는 언어치료의 각 영역별 전문가 체계 도입, 타 학문과의 협업

을 통해 상호 협력적인 치료관계 형성을 중요하게 생각하였다. 3유형이 주장하는 언어치료의 영역별 전문가 체계 도입에 관하여는 현재 언어치료학계 및 현장 실무자들 사이에서 sub-specialty 도입의 필요성이 논의되고는 있으나, 전문가로서 정착된 직업군들처럼 법적으로 제도화되지는 않은 상태이다. 전문분야 제도는 언어치료 서비스의 질적 수준 향상과 지역 사회 내 대상자들에게 상급 수준의 전문적 언어치료 서비스를 제공하게 되므로 언어치료학문이 우리 사회에서 더욱 발전적으로 자리매김하기 위해서는 전문분야 제도 도입이 필요하리라 생각한다.

본 연구는 언어재활사의 ASD 아동의 언어치료에 대한 주관성 유형을 파악함으로써 각 유형별 특성을 이해하고 언어재활사의 치료 업무의 전문성 강화 등의 능력을 향상시키기 위한 전략 방안 마련의 기초자료를 제공하기 위하여 시도하였다. 언어재활사의 ASD 아동의 언어치료에 대한 주관성은 세 가지 유형으로 분류되었다. 연구결과 언어재활사들이 가장 어려워하는 ASD 아동 치료의 전문적 치료 방법 및 기술의 발전을 이루기 위한 체계적이고 세밀한 노력이 필요해 보인다. 언어치료학문이 우리나라에서 사회적으로 꼭 필요한 학문으로 발전해오면서 다각도의 성장 과정을 거쳤다. 그러나 본 연구 결과에서 나타나듯이 ASD 아동의 돌발적인 문제행동 등의 다양한 임상 증상 발생 시 언어재활사들의 대처가 매우 어렵고 힘겨운 상황이다. 따라서 언어치료전공 학부생들의 실습 교육 시 ASD 아동 사례의 매뉴얼 구축 및 슈퍼비전을 강화하여 언어재활사들의 안정적인 치료환경이 이루어지길 바란다. 더불어 언어치료학문을 더욱 체계적이며 발전적으로 주도하기 위하여 전문가 제도의 확립을 위한 언어치료학계의 긍정적 검토 및 노력이 필요할 것으로 생각한다. 이상의 결과를 바탕으로 다음을 제언한다. 1) 언어재활사들의 ASD 아동의 언어치료 업무에 관한 교육 프로그램 개발을 위한 지속적인 연구가 필요하다. 2) 언어재활사들의 전문가 체계 확립 방안 모색을 위한 탐색적 연구가 필요하다. 3) 본 연구는 언어재활사들이 근무하는 지역이 두 곳으로 한정되어 있으며, 경력 및 학력이 다양하게 대상자를 선정한 제한점을 갖고 있어 연구결과를 일반화하는데 제한이 있다.

【참고문헌】

- 김태우(2016), “재활치료사의 직장생활 인식과 관련변인에 대한 연구”, 인하대학교 대학원 박사학위논문.
- 김시영·김시현·장현진·김수형·김주형·김지연(2020), “언어재활사가 현장에서 겪는 어려움 분석 및 지원 방안”, 『언어치료연구』, 29(4): 89-97, <DOI: 10.15724/jslhd.2020.29.4.089>.
- 김유경·장현진(2019), “언어치료사에 대한 은유분석: 고등학생과 예비언어치료사 중심으로”, 『언어치료연구』, 28(2): 183-193, <DOI: 10.15724/jslhd.2019.28.2.183>.
- 김홍규(2008), 『Q 방법론-과학철학, 이론, 분석 그리고 적용』, 서울: 커뮤니케이션북스.
- 신문자(2002), “자폐성 장애 아동을 위한 언어치료”, 『자폐성장장애연구』, 4(1): 65-88.
- 심재찬(2016), “언어재활사 치료역량척도 개발 및 관련변인 연구: 언어재활사 놀이성 및 치료적 관계를 중심으로”, 명지대학교 대학원 박사학위논문.
- 이승희(2014), “DSM-5의 자폐스펙트럼장애에 관한 10문 10답”, 『정서행동장애연구』, 30(3): 1-33, <UCI(KEPA): I410-ECN-0102-2015-300-000182185>.
- 장애통계연보(2019), 『2019 장애통계연보』, 서울: 한국장애인개발원.
- 전선영(2017), “언어재활사로서의 직업적 체험과 기대”, 공주대학교 특수교육대학원 석사학위논문.
- 한유진·이선아(2015), “언어재활사를 위한 슈퍼비전 요구분석: 교육내용 요구도, 심리적 소진과 직무 만족을 중심으로”, 『언어치료연구』, 24(3): 149-160.
- American Psychiatric Association(2013), 『Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)』, Washington, DC: Author.
- Beverly, B. L. & L. A. Mathews(2021), “Speech-Language Pathologist and Parent Perspectives on Speech-Language Patholog Services for Children With Autism Spectrum Disorders”, 『Focus on Autism and Other Developmental Disabilities』, 36(2): 121-132, <DOI: 10.1177/1088357620954380>.
- Cascella, P. W. & C. S. Colella(2004), “Knowledge of autism spectrum disorders among Connecticut school speech-language pathologists”, 『Focus on Autism and Other Developmental Disabilities』, 19(4): 245-252, <DOI: 10.1177/10883576040190040601>.

- Church, C., Alisanski, S., & S. Amanullah(2000), "The social, behavioral, and academic experiences of children with Asperger Syndrome", 『Focus on Autism and Other Developmental Disabilities』, 15(1): 12-20, <DOI: 10.1177/108835760001500102>.
- Lord, C., Shulman, C., & P. DiLavore(2004), "Regression and word loss in autistic spectrum disorders", 『Journal of Child Psychology and Psychiatry』, 45(5): 936-955, <DOI: 10.1111/j.1469-7610.2004.t01-1-00287.x>.
- Loucas, T., Charman, T., Pickles, A., Simonoff, E., Chandler, S., Meldrum, D., & G. Baird(2008), "Autistic symptomatology and language ability in autism spectrum disorder and specific language impairment", 『Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines』, 49(11): 1184-1192, <DOI: 10.1111/j.1469-7610.2008.01951.x>.
- Richard, G. J. (2011), "The role of the speech-language pathologist in identifying and treating children with auditory processing disorder", 『Language, Speech, and Hearing Services in Schools』, 42(3): 241-245, <DOI: 0161-1461(2011/10-0080)>.

<부록 1> 각 유형별 높거나 낮게 동의한 Q 진술문

유형	No	Q 진술문	표준 점수
1	39	아동이 진전을 보일 때 뿌듯하게 느끼며 보람이 있다.	2.34
	29	치료 진전이 없을 때는 논문을 보는 등 공부를 하거나 동료치료사와 케이스 스터디, 토론 등 함께 협업한다.	1.65
	38	언어재활사에 대한 부모의 믿음이 치료 결과에 좋은 영향으로 작용한다.	1.28
	28	의학적인 지식 등 다른 학문들과 협업을 통해 상호 협력하는 치료가 필요하다.	1.10
	23	학령기 고기능 ASD 아동 치료는 상위언어적인 접근을 한다.	1.10
	33	부모와 나의 목표가 다를 때 수용할 부분은 수용하고 부모와 대화로 조정한다.	1.09
	18	무발화 ASD 아동은 의사소통 기능을 중심으로 중재한다.	1.01
	36	ABA 치료에 대해 맹신하는 부모가 많다.	-1.13
	40	ASD 아동은 치료하면서도 호전될 것이라는 기대가 낮다.	-1.30
	1	아동의 공격적인 문제행동(꼬집고, 때리고 등) 및 연령에 맞게 놀아주는 일이 육체적으로 힘들다.	-1.31
	6	한꺼번에 여러 가지 치료를 하는 것은 아동에게 혼란을 주며, 치료 시 질적 상호작용도 어렵다.	-1.45
	2	구어산출이 어려운 아동은 특히 문제행동이 많아 치료하기 어렵다.	-1.48
	34	부모 상담 시 아동이 잘 못하는 부분을 주로 강조하여 설명한다.	-1.57
2	22	아동의 컨디션을 고려하지 않고 나의 치료계획대로 언어적인 자극을 준다.	-2.34
	15	우리나라는 언어치료를 모르는 사람이 아직도 많으며, 자폐에 대한 이해도가 낮다.	1.66
	25	발화산출을 위해 눈, 손 협응 내지 인지활동 등을 같이 진행한다.	1.55
	3	무발화 ASD는 모방이 어려워 말소리를 하나하나 만들어줘야 하는 부분이 힘들다.	1.53
	1	아동의 공격적인 문제행동(꼬집고, 때리고 등) 및 연령에 맞게 놀아주는 일이 육체적으로 힘들다.	1.44
	4	치료에 대한 진전이 보이지 않고 정체기가 올 때 가장 힘들다.	1.38
	37	아동과 부모와의 질적인 상호작용이 결여되면 치료의 한계가 있다.	1.34
	26	상황이 달라지면 적용을 못하므로 거의 모든 상황을 새로 가르쳐야 해서 힘들다.	1.23
	33	부모와 나의 목표가 다를 때 수용할 부분은 수용하고 부모와 대화로 조정한다.	1.04
	10	언어치료학과의 실습시간 등의 커리큘럼 개편이 필요하다.	-1.09
	20	ABA 후의 치료는 아동의 기분을 맞추는데 급급하여 시간을 허비하게 되며, 치료효과도 떨어진다.	-1.13

	12	언어재활사가 전문성을 인정받고 제대로 된 대우를 받으려면 정책이 바뀌어야 한다.	-1.13
	16	언어재활사도 각 영역(ASD, 말더듬 등)의 분야별 전문가 체계를 도입하여 제도화해야 한다.	-1.15
	7	치료 도구는 인터넷, 최신 저널을 검색하는 등 스스로 공부해서 직접 만들어 사용한다.	-1.32
	34	부모 상담 시 아동이 잘 못하는 부분을 주로 강조하여 설명한다.	-1.61
	36	ABA 치료에 대해 맹신하는 부모가 많다.	-2.19
	22	아동의 컨디션을 고려하지 않고 나의 치료계획대로 언어적인 자극을 준다.	-2.26
3	16	언어재활사도 각 영역(ASD, 말더듬 등)의 분야별 전문가 체계를 도입하여 제도화해야 한다.	1.91
	18	무발화 ASD 아동은 의사소통 기능을 중심으로 중재한다.	1.62
	38	언어재활사에 대한 부모의 믿음이 치료 결과에 좋은 영향으로 작용한다.	1.43
	39	아동이 진전을 보일 때 뿌듯하게 느끼며 보람이 있다.	1.43
	37	아동과 부모와의 질적인 상호작용이 결여되면 치료의 한계가 있다.	1.36
	31	치료 후 아동의 예후에 대해 약속은 하지 않는다.	1.10
	28	의학적인 지식 등 다른 학문들과 협업을 통해 상호 협력하는 치료가 필요하다.	1.07
	7	치료 도구는 인터넷, 최신 저널을 검색하는 등 스스로 공부해서 직접 만들어 사용한다.	-1.02
	11	언어치료 하는데 특별히 선호하는 장애유형은 없다.	-1.02
	5	분노조절이 어려운 아동은 우선 화가 나지 않도록 하는데 초점을 맞추게 되므로 치료 목표를 달성하기 어렵다.	-1.15
	26	상황이 달라지면 적용을 못하므로 거의 모든 상황을 새로 가르쳐야 해서 힘들다.	-1.29
	40	ASD 아동은 치료하면서도 호전될 것이라는 기대가 낮다.	-1.67
	34	부모 상담 시 아동이 잘 못하는 부분을 주로 강조하여 설명한다.	-2.23
	22	아동의 컨디션을 고려하지 않고 나의 치료계획대로 언어적인 자극을 준다.	-2.45

